การประชุมนำเสนอผลการศึกษาและเสวนานโยบาย · 26 ตุลาคม 2569

ความก้าวหน้า ไม่ได้เกิดขึ้นเอง

ข้อค้นพบและข้อเสนอเชิงนโยบาย จากโครงการวิจัย
การพัฒนาแนวทางและนโยบายการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ
โดยใช้แบบจำลองแบบบูรณาการ

นพ.พีรสิชฌ์ สิทธิรัตน์ หัวหน้าโครงการ
หน่วยวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



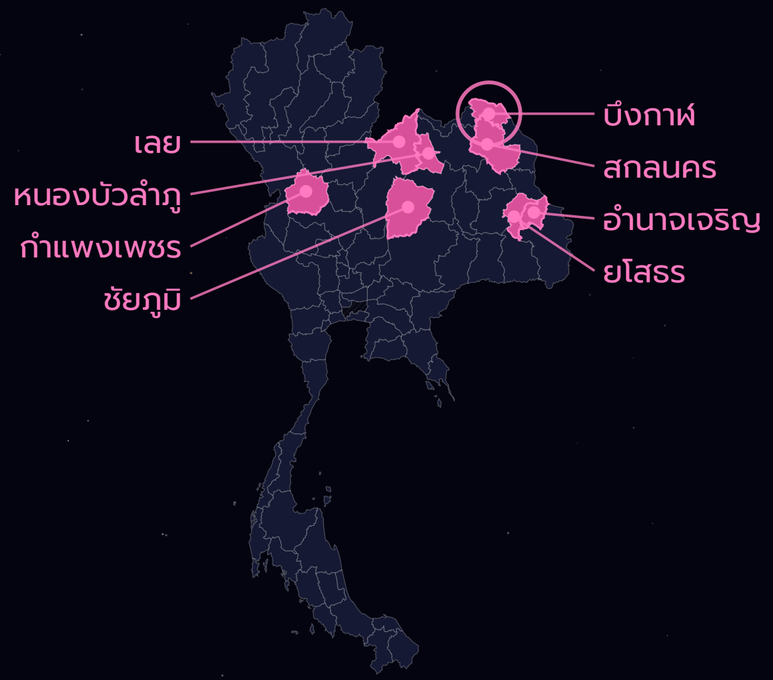
101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สิบสองปีที่ผ่านมา · ผลจากข้อมูล

ความก้าวหน้าเป็นของจริง

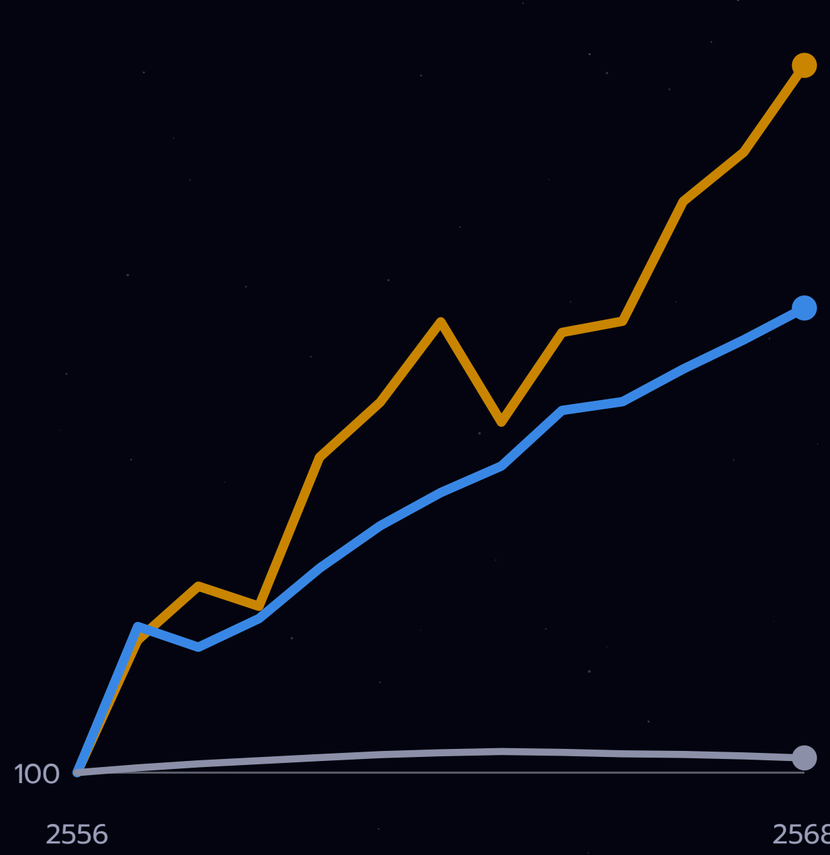
แพทย์และพยาบาลเพิ่มเร็วกว่าประชากรมาก
แต่บางพื้นที่ยังมีคนให้บริการน้อย

8 จังหวัดมีแพทย์กระทรวงเทียบฐานวัด**ต่ำทั้งสี่วิธี** รวมบึงกาฬ
คำถามจึงอยู่ที่ว่า คนเพิ่มขึ้นแล้ว แต่ทำไมบางพื้นที่ยังขาด



เพิ่มขึ้นเท่าใดจากปี 2556

ให้ปี 2556 เริ่มที่ 100 เท่ากัน



บุคลากรทุกสังกัด พ.ศ. 2556–2568 (รายงานทรัพยากรสาธารณสุข) · พยาบาลวิชาชีพรวมพยาบาลเทคนิค · ประชากรจากทะเบียนราษฎรรายอายุ · แผนที่: แพทย์กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มต่ำสุดทั้งสี่วิธีวัด · รายงานการศึกษา บทที่ 4

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

แผนที่ของเรื่องวันนี้ · แผนภาพเชิงแนวคิด

มีสิทธิรับบริการแล้ว ต้องมีคนทำงานรองรับ

ประชาชนจะได้รับบริการ เมื่อสิทธิที่กำหนดไว้มีคนทำงานรองรับ ตั้งแต่การฝึก การจ้าง จนถึงการทำงานอยู่ต่อได้

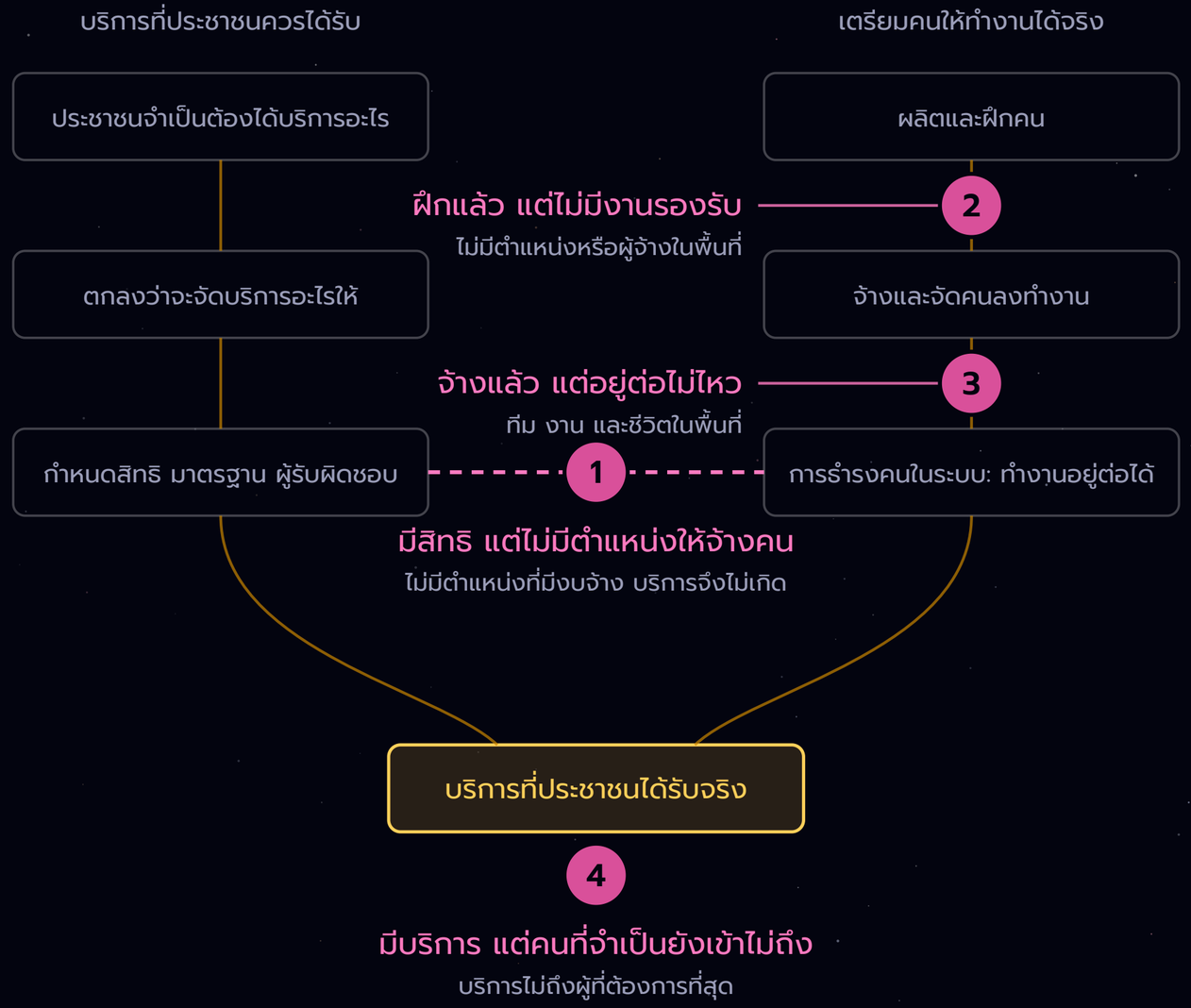
ต้องกำหนดบริการและเตรียมคนให้ทำงานรองรับ
จึงจะเกิดบริการที่ประชาชนได้รับจริง
การบรรยายวันนี้มีสี่ช่วง

หนึ่ง
นับอย่างไร

สอง
ทำไมความเหลื่อมล้ำสะสม

สาม
เพิ่มตำแหน่งให้พื้นที่ขาด

สี่
ใครรับภาระ



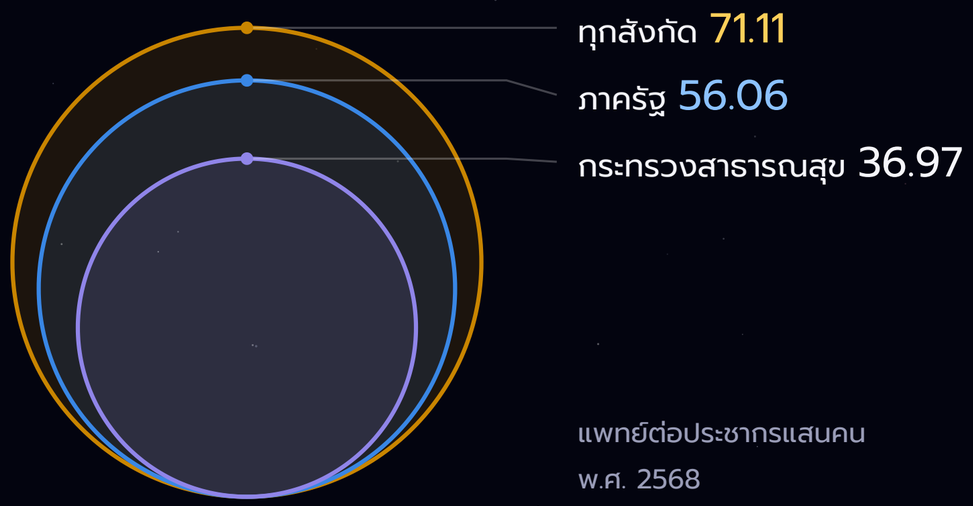
101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หนึ่ง · นับอย่างไร ● ผลจากข้อมูล

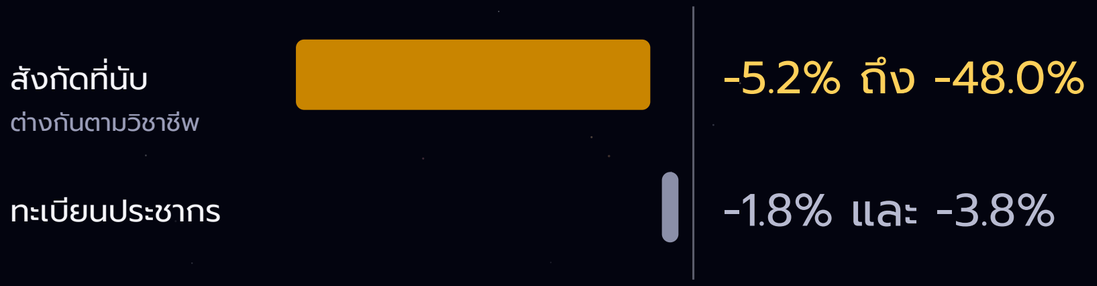
หมอพอไหม ต้องบอกว่านับใคร และเทียบกับอะไร

นับเฉพาะหมอกระทรวง หรือรวมรัฐและเอกชนด้วย ได้คำตอบต่างกันมาก

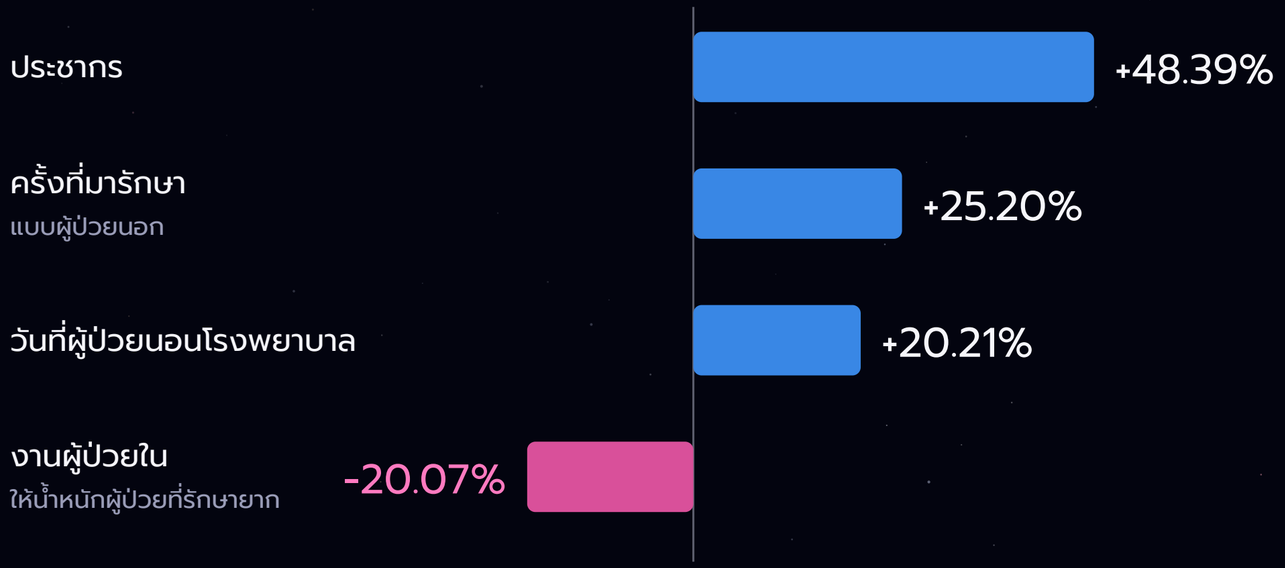
แพทย์กระทรวงชุดเดียวกัน เทียบกับประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.39 แต่เทียบกับงานผู้ป่วยในที่ให้น้ำหนักผู้ป่วยที่รักษายาก**ลดลงร้อยละ 20.07**



บุคลากรต่อประชากรลดลงเท่าใด เมื่อเปลี่ยนสิ่งที่นับ (%)



แพทย์กระทรวงชุดเดียวกัน เทียบกับอะไรจึงเห็นว่าเพิ่มหรือลด (%)



แพทย์ต่อประชากรแสนคน พ.ศ. 2568 · ช่วงยาว พ.ศ. 2556–2568 ยกเว้นงานผู้ป่วยใน (AdjRW) ปีงบ 2561–2568 ซึ่งส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบจัดกลุ่มโรค · รายงานการศึกษา บทที่ 4

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หนึ่ง · นับอย่างไร ● ผลจากข้อมูล

เปลี่ยนไม้บรรทัด รายชื่อจังหวัดที่ขาด ก็เปลี่ยน

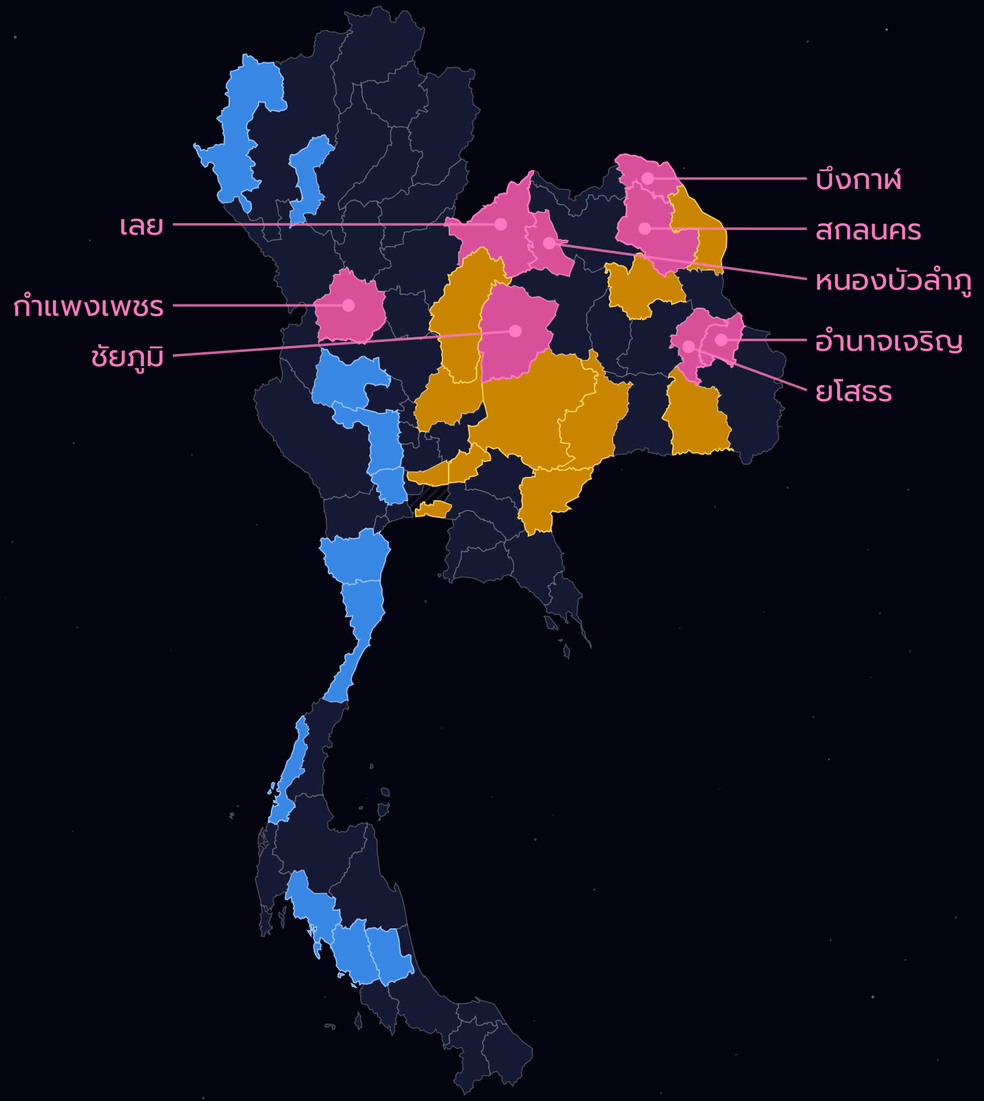
เทียบแพทย์กระทรวงของ 76 จังหวัดกับฐานวัดหกแบบ แล้วดูว่า 19 จังหวัดที่ได้ค่าต่ำสุดเปลี่ยนหรือไม่

8 จังหวัดที่ต่ำทั้งสี่วิธีควรได้รับความสำคัญก่อน ส่วนจังหวัดที่ผลต่างกันต้องตรวจเพิ่ม

สี่ฐานหลัก

ประชากร · บริการที่ทำจริง · บริการที่แบบจำลองปรับให้เทียบกันได้ · ภาระโรค

- ต่ำทั้งสี่วิธี 8 จังหวัด
- ต่ำเมื่อเทียบภาระโรค แต่ไม่ต่ำเมื่อเทียบบริการ 11 จังหวัด
- ต่ำเมื่อเทียบบริการ แต่ไม่ต่ำเมื่อเทียบภาระโรค 11 จังหวัด



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

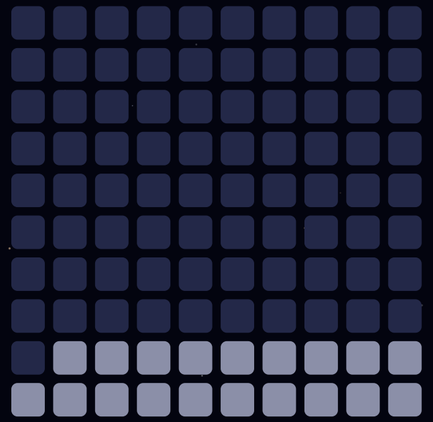
หนึ่ง · นับอย่างไร ● ผลจากข้อมูล

จังหวัดที่ป่วยมาก มักมีหมอน้อย

สังคมสูงวัย เจ็บป่วยเพิ่มแม้คนเพิ่มไม่มาก

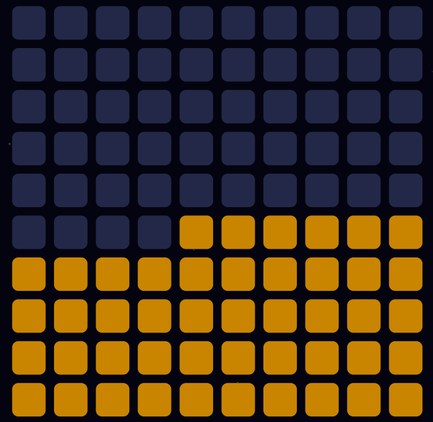
คนอายุหกสิบปีขึ้นไป

ส่วนในประชากร



18.7%

ส่วนในปีสุขภาพดีที่สูญเสีย



45.5%

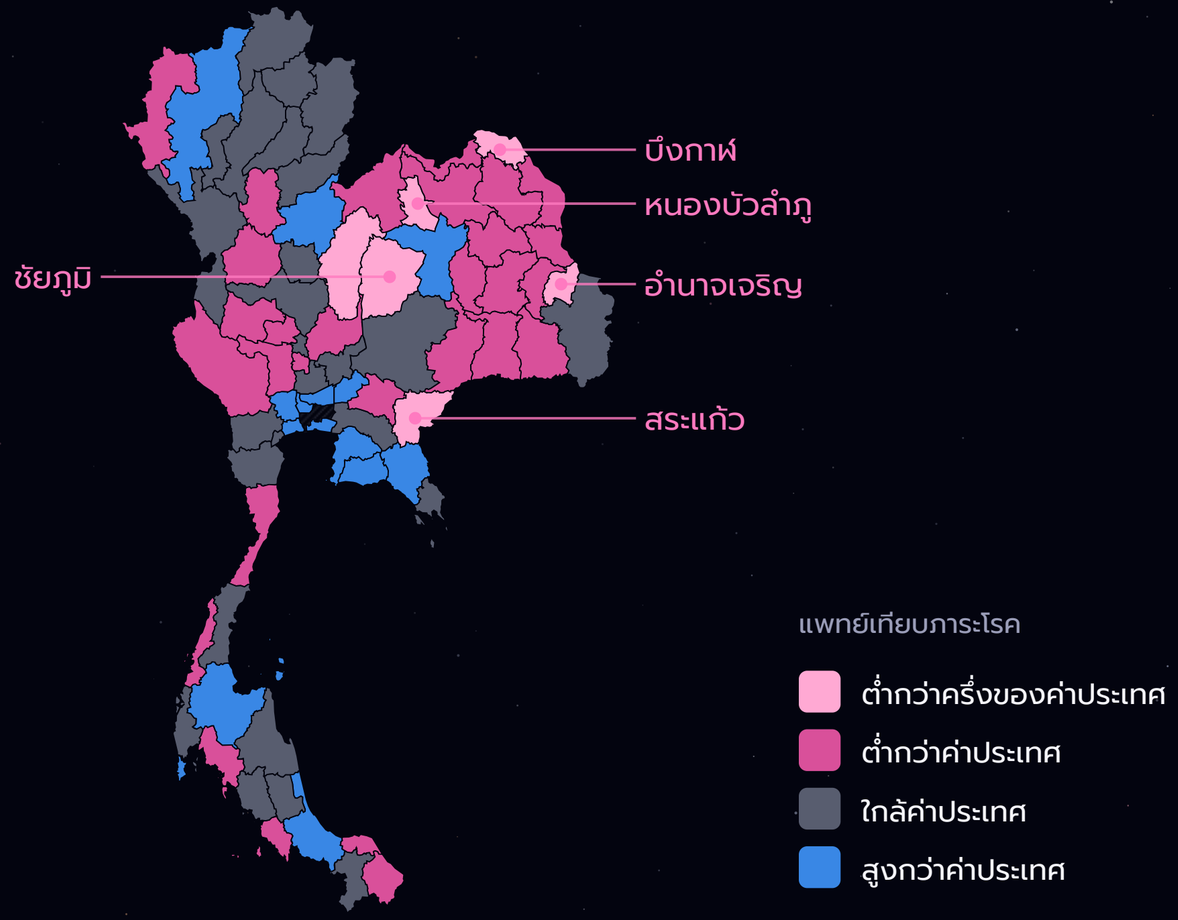
พ.ศ. 2556–2568 ภาระโรคที่คำนวณ +21.1% ประชากร +2.0%

ให้อัตราของแต่ละวัยคงเดิม

แพทย์อยู่มากในจังหวัดที่ป่วยน้อยกว่า

-0.111 ค่าติดลบสรุปทิศทางนี้

แผนที่: แพทย์ทุกสังกัดต่อประชากรที่ให้น้ำหนักตามภาระโรค เทียบกับประเทศ · พ.ศ. 2568



ภาระโรครายจังหวัด BOD 2022 (IHPP) · ภาระคาดหมายตรึงอัตรารายอายุ · แผนที่: แพทย์ทุกสังกัด พ.ศ. 2568 (รายงานทรัพยากรสาธารณสุข) ต่อประชากรที่ถ่วงด้วยภาระโรคปรับอายุ เทียบค่าประเทศ · รายงานการศึกษา บทที่ 4

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สอง · ทำไมความเหลื่อมล้ำสะสม

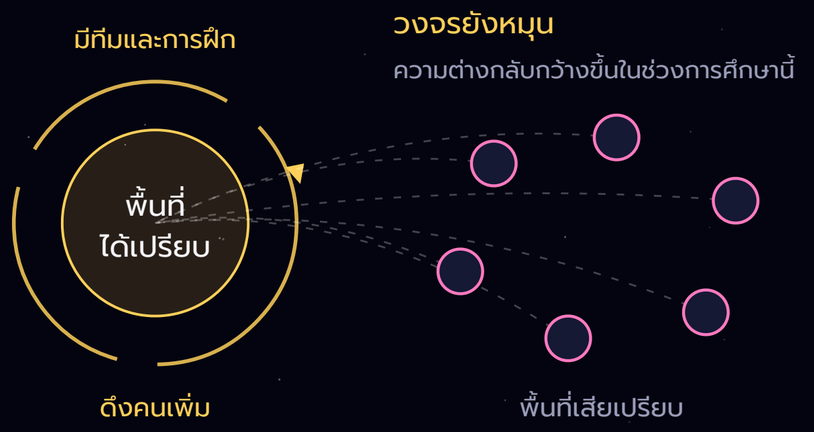
แผนภาพเชิงแนวคิด

พื้นที่ที่พร้อมยิ่งได้คนเพิ่ม ต้องมีนโยบายช่วยพื้นที่ที่ขาด

วงจรของ Myrdal: พื้นที่ที่มีทีมและการฝึกดึงคนเพิ่ม
คนที่เพิ่มช่วยขยายบริการและการฝึก จึงยิ่งดึงคนได้
ต้องมีนโยบายช่วยพื้นที่ที่เสียเปรียบ

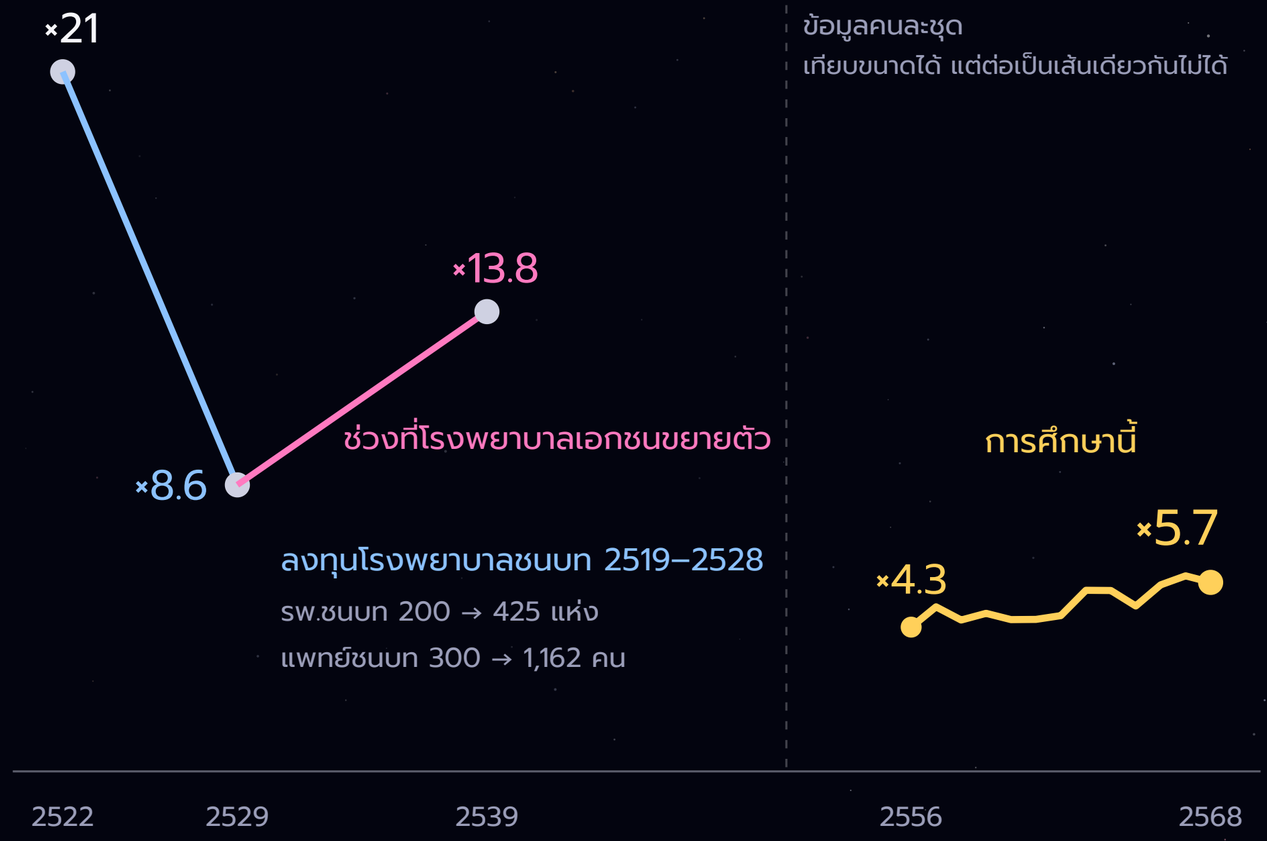
ความต่างแคบลงในช่วงที่**รัฐตัดสินใจลงทุน** ไม่ได้แคบลงเองตามเวลา
ทั้งการให้แพทย์ชดใช้ทุนและการลงทุนโรงพยาบาลชนบท
ข้อมูลนี้ยังแยกผลของแต่ละนโยบายไม่ได้

ในข้อมูลของการศึกษานี้ แม้แพทย์รวมเพิ่มมาก ความต่างกลับกว้างขึ้นจาก **4.3** เป็น **5.7 เท่า**



แพทย์ต่อประชากร กรุงเทพฯ สูงกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือกี่เท่า

ผลจากข้อมูล



ช่วงหลังเป็นข้อมูลของการศึกษานี้ (บุคลากรทุกสังกัด ประชากรทะเบียนราษฎร) คนละชุดกับในอดีต เทียบได้ในระดับขนาด ประชากรตามทะเบียนของกรุงเทพฯ ต่ำกว่าคนที่อยู่จริง ค่ากรุงเทพฯ จึงสูงกว่าที่เป็นจริง

Myrdal 1957 · Wibulpolprasert & Pengpaibon 2003 · ช่วง พ.ศ. 2556–2568 จากข้อมูลของการศึกษานี้ (บุคลากรทุกสังกัด ทะเบียนราษฎร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด) · รายงานการศึกษา บทที่ 1 และ 4 · วงจรเป็นแผนภาพเชิงแนวคิด เส้นประยังต้องตรวจสอบ

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สอง · ทำไมความเหลื่อมล้ำสะสม ● ผลจากข้อมูล

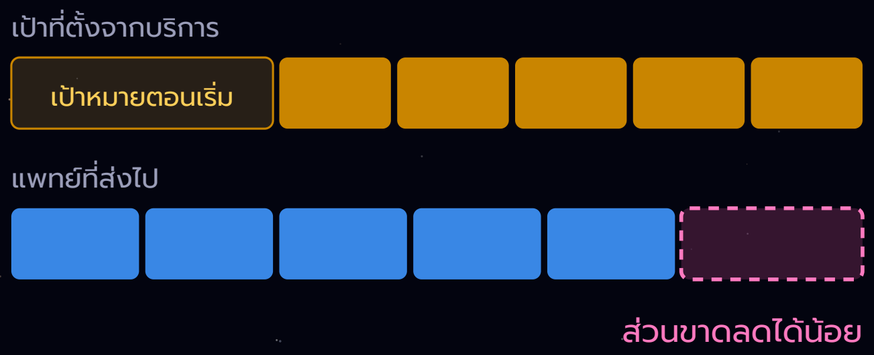
ทรัพยากรดึงทรัพยากร: ที่ที่มีพร้อมยิ่งได้เพิ่ม

ทีม การฝึก และตำแหน่งยังกระจุกอยู่ในบางพื้นที่

ถ้าใช้บริการที่ทำได้เป็นเกณฑ์เดียว **เพิ่มแพทย์แล้วบริการเพิ่ม เป้าที่ตั้งจากบริการจึงเพิ่มตาม** ส่วนขาดจึงลดได้น้อย

แพทย์เพิ่มหนึ่งคน

เป้าหมายเพิ่ม 0.88 คน



ช่องฟ้าคือแพทย์หนึ่งคน ช่องทองทึบคือเป้าที่เพิ่มตาม · ผลจากแบบจำลอง

แพทย์เฉพาะทาง

63.5%

อยู่ในสถานพยาบาลหนึ่งในสิบที่มีแพทย์เฉพาะทางมากที่สุด

จาก 61.6% ใน พ.ศ. 2564

ตำแหน่งที่มีงบจ้าง

×3.4

ตำแหน่งแพทย์กระทรวงต่อประชากร

จังหวัดสูงสุดเทียบต่ำสุด



เตียงกับวันนอน

เตียงมากขึ้น 1%

วันนอนมากขึ้น 0.708%

ความสัมพันธ์ ไม่ใช่ผลเชิงสาเหตุ

ตำแหน่งว่าง

18.9%

ใน รพ.ชุมชนขนาดเล็ก

รพ.ศูนย์ 5.6%

แพทย์เฉพาะทาง ทุกสังกัด ไม่รวมแพทย์ทั่วไป พ.ศ. 2564–2567 · ตำแหน่ง จ.18 ณ 1 มิ.ย. 2569 · รายงานการศึกษา บทที่ 4 และ 5

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

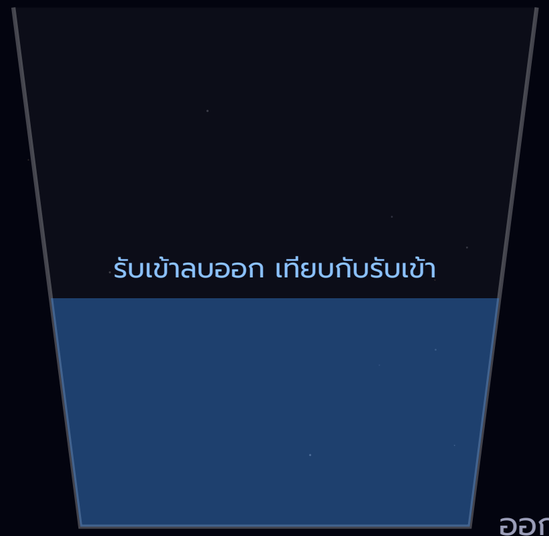
สอง · ทำไมความเหลื่อมล้ำสะสม ● ผลจากข้อมูล

ถังที่รั่ว: ผลิตเพิ่มอย่างเดียวไม่พอ

พยาบาลที่รับเข้ามาจำนวนมาก ต้องทดแทนคนที่ออกไป จึงเหลือคนเพิ่มไม่มาก

ต่อพยาบาลร้อยคนต่อปี รับเข้า **9.57** ครั้ง ออก **8.06** ครั้ง การออกส่วนใหญ่เป็นการลาออก

แพทย์



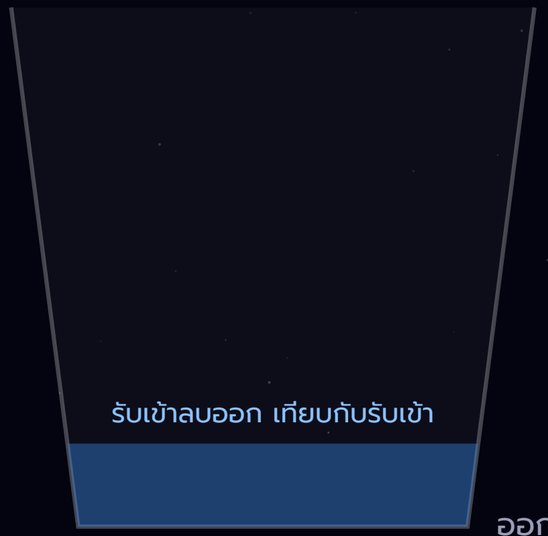
รับเข้า 19,744 ครั้ง

0.56

เหตุการณ์ออก ÷ รับเข้า

ออก 11,136 ครั้ง

พยาบาลวิชาชีพ



รับเข้า 99,365 ครั้ง

0.84

เหตุการณ์ออก ÷ รับเข้า

ออก 83,706 ครั้ง

นับเป็นครั้ง คนเดิมอาจนับซ้ำ · ระดับน้ำคือรับเข้าลบออก เทียบกับรับเข้า ไม่ใช่การติดตามว่าผู้รับใหม่ยังอยู่กี่คน

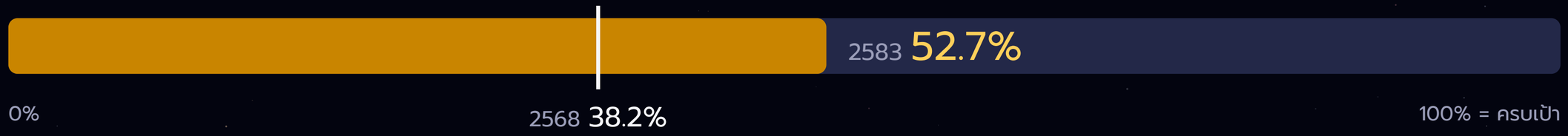
101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สาม · เพิ่มตำแหน่งให้พื้นที่ขาด ◆ ผลจากแบบจำลอง

สูตรบอกว่าใครขาดมากกว่า ส่วนขาดเท่าใดต้องกำหนดเป้าหมาย

สมมติว่ามีผู้ตอบรับเริ่มงานปีละ 2,000 คน ถึงปี 2583 ทุกจังหวัดยังต่ำกว่าเป้าตัวอย่าง
ย้ายคนกันก็ไม่ลดส่วนขาดรวม

จำนวนแพทย์กระทรวงเป็นร้อยละของเป้าตัวอย่าง 1:1,000 ประชากรที่กระทรวงรับผิดชอบ (ไม่ใช่มาตรฐานกระทรวง)



แพทย์กระทรวง 22,685 → 29,214 คน (2568 → 2583) · เป้าตัวอย่างปี 2568 ต้องมี 59,316 คน

จำนวนแพทย์ที่ยังขาดจากเป้า ปี 2583



ลดได้ด้วยการย้ายระหว่างจังหวัด
0 คน

ทุกจังหวัดยังต่ำกว่าเป้า ย้ายไปเติมที่หนึ่งก็ทำให้อีกที่ขาด ส่วนขาดรวมจึงไม่ลด · ผลจากแบบจำลอง

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สาม · เพิ่มตำแหน่งให้พื้นที่ขาด ◆ ผลจากแบบจำลอง

ตำแหน่งเต็มแล้ว แพทย์ใหม่ลงได้เฉพาะที่ว่าง

มีตำแหน่งแพทย์ที่มีงบจ้าง 28,925 ตำแหน่ง ว่าง 2,813 ตำแหน่ง รับผู้ปฏิบัติงานเพิ่มได้ราว 2,444 คน ถ้าไม่เพิ่มตำแหน่ง แบบจำลองพบว่าจะเต็มปี 2572

ไม่มีตำแหน่งว่าง ก็รับแพทย์ใหม่ไม่ได้ จะแบ่งแพทย์ใหม่ด้วยเกณฑ์ใด 19 จังหวัดที่ต่ำสุดในปี 2583 ก็ได้**เท่ากัน**

เกณฑ์แบ่งแพทย์ใหม่ · แพทย์เทียบเป้าใน 19 จังหวัดที่ต่ำสุดในปี 2583

ประชากร	33.7%
บริการที่คำนวณให้เทียบกันได้	33.7%
ภาระโรค	33.7%

เท่ากันทุกสูตร

ถ้าไม่เพิ่มตำแหน่ง · แต่ละช่องคือหนึ่งจังหวัด

เต็มปี 2572

ภาพนี้คือ พ.ศ. 2583

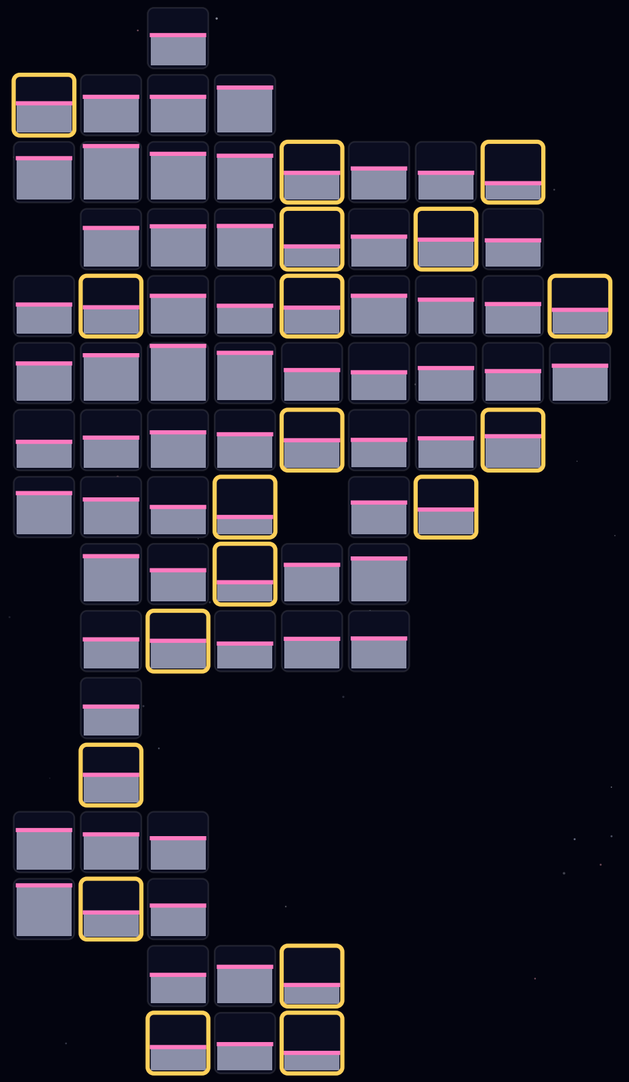
- แพทย์เต็มตำแหน่งแล้ว
- จำนวนที่ตำแหน่งรองรับได้
- 19 จังหวัดที่ขาดที่สุดในปีตั้งต้น

แพทย์ใหม่ที่ไม่มีตำแหน่งรองรับ (สะสม)

5,442

คน ถึง พ.ศ. 2583

ไม่ได้แปลว่าตกงานทั้งหมด



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สาม · เพิ่มตำแหน่งให้พื้นที่ขาด ◆ ผลจากแบบจำลอง

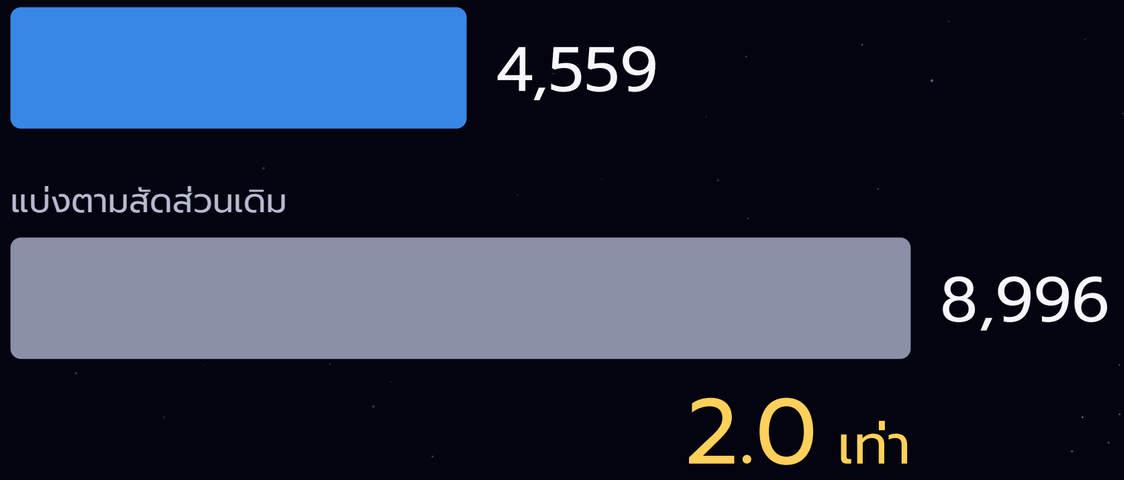
เพิ่มตำแหน่งให้พื้นที่ขาดก่อน ใช้เพียงครึ่งเดียวก็ได้ผลเท่ากัน

เพิ่มตำแหน่งที่มีงบจ้างร้อยละห้าทุกห้าปี รวม 4,559 ตำแหน่งในสิบห้าปี เปรียบเทียบแบ่งตามสัดส่วนเดิม กับให้พื้นที่ขาดก่อน

เพิ่มตำแหน่งเท่ากัน 4,559 ตำแหน่ง · ผลปี 2583

	แบ่งตามสัดส่วนตำแหน่งเดิม		ให้พื้นที่ขาดก่อน
19 จังหวัดที่ต่ำสุดในปี 2583 % ของเป้า	39.0%	→	43.7%
ความต่างระหว่างจังหวัด Gini ยิ่งต่ำยิ่งต่างกันน้อย	0.127	→	0.090
แพทย์ตามสัญญา ที่ไม่มีตำแหน่งให้กลับภูมิลำเนา (คน)	590	→	3

ตำแหน่งที่ต้องเพิ่ม เพื่อให้กลุ่มจังหวัดที่ขาดได้ผลเท่ากัน



รอบตำแหน่ง 2570–2574 ที่กำลังจัดทำ

24 จังหวัด ควรได้ตำแหน่งใหม่ตรงกันในเกณฑ์ที่ทดลอง

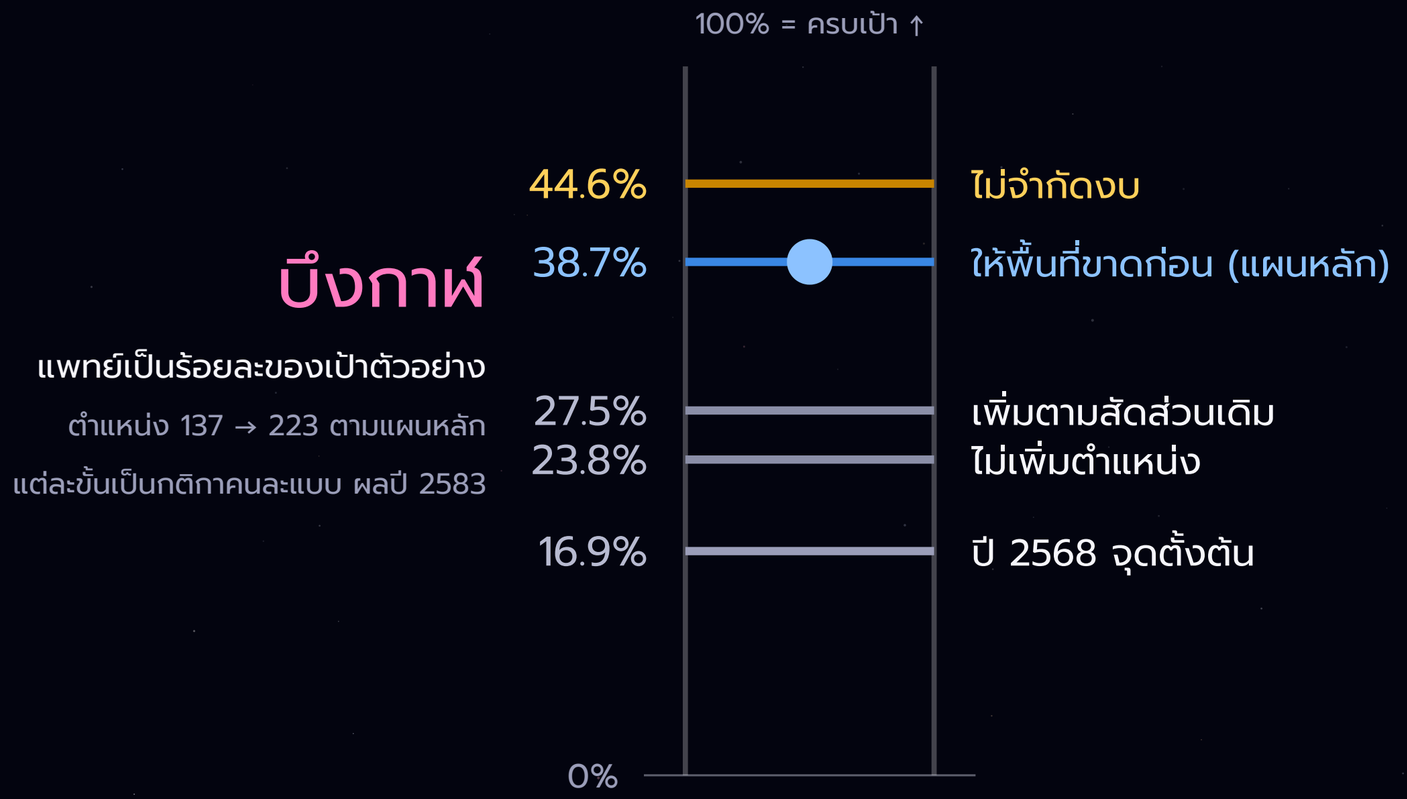
ขาดแพทย์ 16 จังหวัด · ต้องรับแพทย์ตามสัญญาหรือผู้กลับจากฝึกอบรม 8 จังหวัด

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สาม · เพิ่มตำแหน่งให้พื้นที่ขาด ◆ ผลจากแบบจำลอง

บันไดของบึงกาฬ

บึงกาฬมีแพทย์กระทรวง 72 คน ตำแหน่งที่มีงบจ้าง 137 ตำแหน่ง แพทย์ออกราวร้อยละ 13.4 ต่อปี
แต่ละขั้นบันไดคือผลจำลองเมื่อใช้กติกาต่างกัน



แพทย์ของบึงกาฬเป็นร้อยละของเป้าตัวอย่าง พ.ศ. 2583 ภายใต้แต่ละกติกา · แผนหลักเพิ่มตำแหน่งเป็น 223 ตำแหน่ง · ผลตามสมมติฐาน ไม่ใช่การพยากรณ์ · รายงานการศึกษา บทที่ 5

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สาม · เพิ่มตำแหน่งให้พื้นที่ขาด ◆ ผลจากแบบจำลอง

ใครจ่ายค่าจ้าง สำคัญกว่าจ้างแบบไหน

ลองลดตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง แล้วจ้างลูกจ้างทดแทนให้รับคนได้เท่าเดิม ใครจ่ายและให้พื้นที่ใดก่อน เปลี่ยนผลได้มาก

ถ้าโรงพยาบาลจ้างจากรายได้ของตัวเอง ลูกจ้างจะไปอยู่ที่จังหวัดที่มีบริการมาก
ถ้า**ส่วนกลางจ่ายและให้พื้นที่ขาดก่อน** พื้นที่รายได้น้อยจึงรับคนได้
ไม่ต้องปล่อยให้จำนวนคนขึ้นกับรายได้โรงพยาบาล

ลูกจ้างรอบแรกที่อยู่ใน 19 จังหวัดที่ขาดที่สุดในปีตั้งต้น

17%

โรงพยาบาลจ่าย

19 จังหวัดที่ต่ำสุดในปี 2583
แพทย์ได้ 39.6% ของเป้า

49%

ส่วนกลางจ่าย

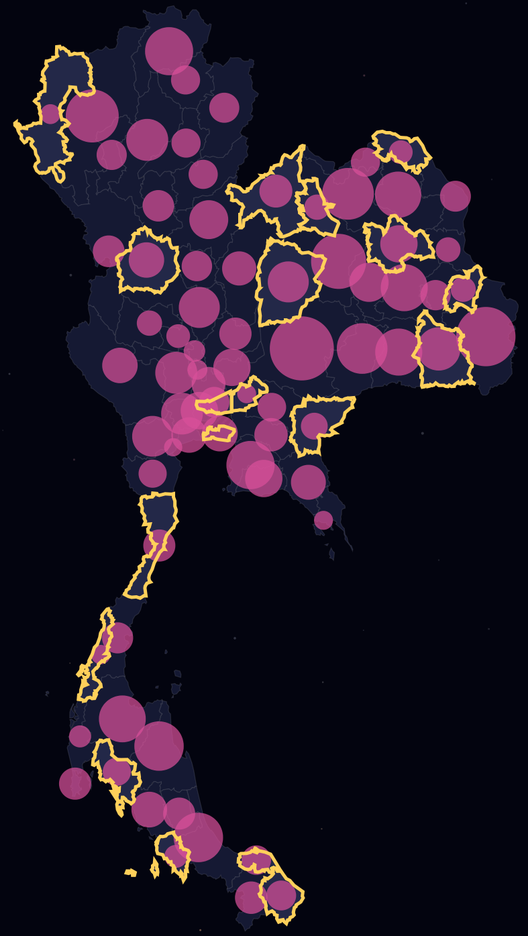
19 จังหวัดที่ต่ำสุดในปี 2583
แพทย์ได้ 48.8% ของเป้า

เส้นทอง = 19 จังหวัดที่ขาดที่สุดในปีตั้งต้น

ขนาดวง = จำนวนลูกจ้างในจังหวัด

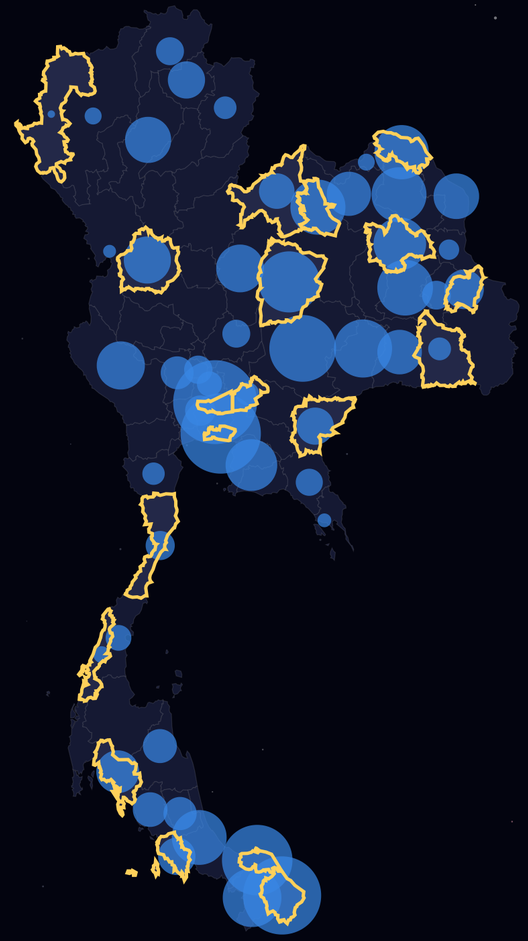
โรงพยาบาลจ่ายจากรายได้ของตน

ใช้ปริมาณบริการประมาณส่วนแบ่งรายได้
เพราะไม่มีข้อมูลการเงินโรงพยาบาล



ส่วนกลางจ่าย ให้พื้นที่ขาดก่อน

จัดลูกจ้างให้จังหวัดที่ขาดก่อน
ไม่ขึ้นกับรายได้ของโรงพยาบาล



ผลจำลอง: ลดตำแหน่งข้าราชการที่ว่างร้อยละห้าต่อรอบ เพิ่มลูกจ้างแทน · สมมติลูกจ้างมีอัตราออกเท่าข้าราชการ · ลูกจ้างรอบแรก · รายงานการศึกษา บทที่ 5

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

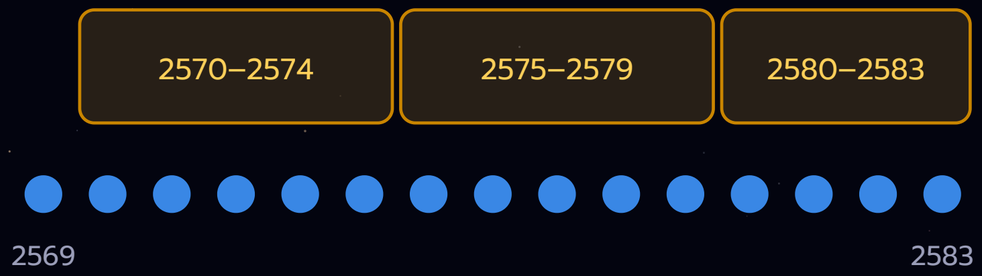
สาม · เพิ่มตำแหน่งให้พื้นที่ขาด ◆ ผลจากแบบจำลอง

จัดแพทย์ใหม่ทุกปี และบอกข้อจำกัดของแบบจำลอง

ทบทวนตำแหน่งทุกห้าปี จัดแพทย์ใหม่ทุกปีตามตำแหน่งที่ว่างจริง

เรากำหนดเกณฑ์ไว้ก่อนทดสอบกับข้อมูลอดีต ผ่านหนึ่งด้าน ไม่ผ่านสองด้าน จึงใช้**เปรียบเทียบทางเลือกตามสมมติฐาน**ได้ แต่ไม่ใช้เป็นรายชื่อจัดสรรตายตัว รายชื่อจังหวัดต้องทบทวนทุกปี

ทบทวนตำแหน่ง · ทุกห้าปี



จัดแพทย์ใหม่ · ทุกปี

ตามตำแหน่งที่ว่างจริง

	กำหนดล่วงหน้าตลอดสิบห้าปี	จัดใหม่ทุกปี
แพทย์ที่แผนส่งไปจังหวัดไม่มีตำแหน่งว่าง ยอดสะสมสิบห้าปี เฉลี่ยต่ออนาคตจำลองหนึ่งแบบ	1,193	→ 1,003
แพทย์เทียบเป้าใน 19 จังหวัด ที่ต่ำสุดในปี 2583 (% ของเป้า)	42.2%	→ 44.4%

กำหนดล่วงหน้า: เฉลี่ยจาก 500 อนาคตจำลอง
จัดใหม่ทุกปี และแถว % ของเป้า: เทียบคู่ใน 60 อนาคตแรกของชุดเดียวกัน

ทดสอบกับข้อมูลอดีต · เกณฑ์กำหนดก่อนทดสอบ

1 · จำนวนแพทย์รายจังหวัดคลาดเคลื่อนเท่าใด — ผ่าน
28.1 คนต่อจังหวัด · ค่าเดิม 33.3 · ตามประชากร 32.8

2 · ค่าจริงอยู่ในช่วงที่คาดไว้บ่อยพอหรือไม่ — ไม่ผ่าน
0.44 · เกณฑ์ 0.80–0.98

3 · รายชื่อจังหวัดที่ขาดตรงกับข้อมูลจริงหรือไม่ — ไม่ผ่าน
0.59 · เกณฑ์ 0.60 · รายชื่อเดิม 0.72

500 อนาคตจำลอง (เทียบคู่กับการจัดใหม่ทุกปีใน 60 อนาคตแรก) · ทดสอบกับข้อมูลอดีตตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนทดสอบ · รายงานการศึกษา บทที่ 5

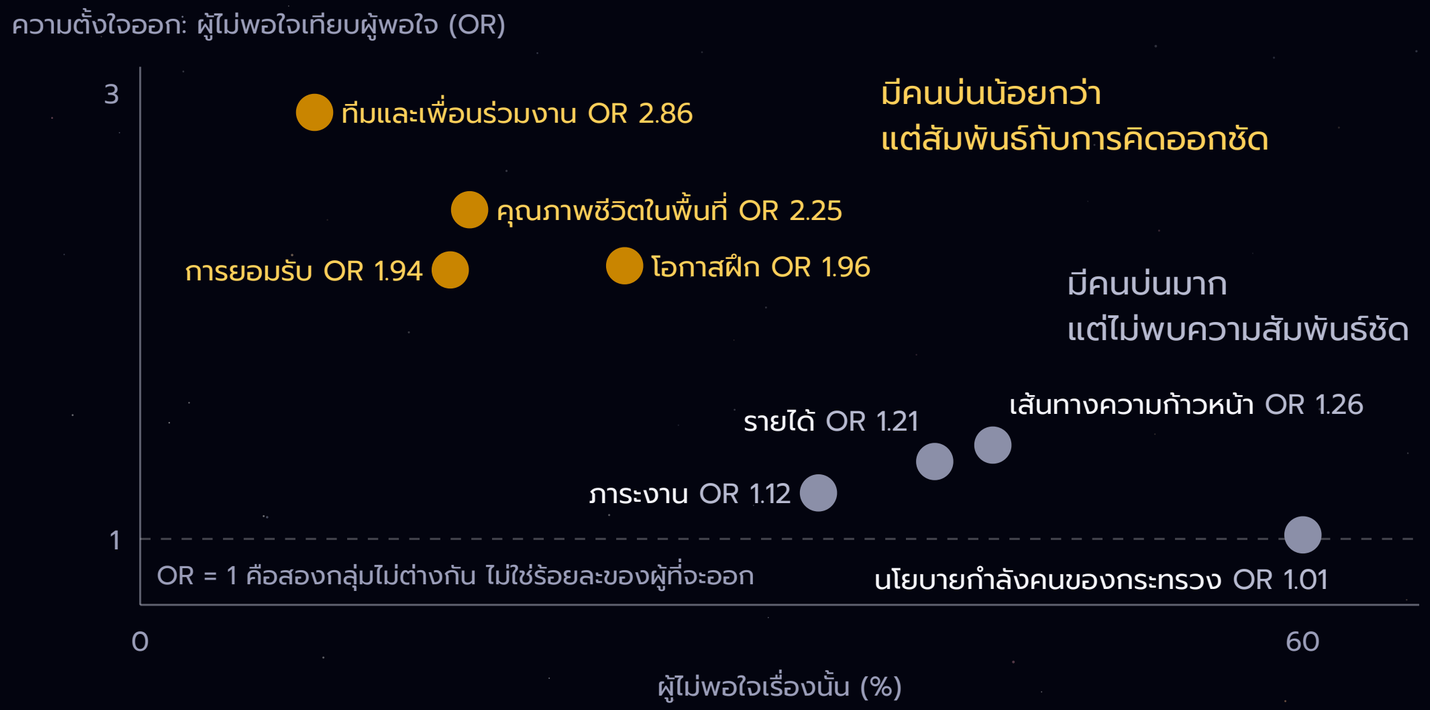
101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สี่ · ใครรับภาระ ● ผลจากข้อมูล

เรื่องที่คนบ่นมาก อาจไม่ใช่เรื่องที่สัมพันธ์กับการคิดออก

สำรวจผู้ปฏิบัติงาน 734 คน จาก 110 หน่วยบริการใน 66 จังหวัด
ร้อยละ 16 คิดออกจากราชการหรือสังกัดภายในสามปี

ผู้ทำงานในพื้นที่ทุรกันดารและผู้ที่การจ้างไม่มั่นคงคิดออกมากกว่า
ส่วนการทำงานในจังหวัดบ้านเกิดสัมพันธ์กับการคิดย้ายพื้นที่น้อยลง แต่ไม่พบความสัมพันธ์ชัดกับการออกจากสังกัด



ปัจจัยเชิงโครงสร้าง

พื้นที่ทุรกันดาร OR 2.35
→ คิดออกจากสังกัดมากกว่า

การจ้างไม่มั่นคง OR 2.26
→ คิดออกจากสังกัดมากกว่า

ทำงานจังหวัดบ้านเกิด OR 0.44
→ คิดย้ายพื้นที่น้อยกว่า

ความสัมพันธ์จากผู้ที่ยังทำงาน ไม่ใช่เหตุและผล

การสำรวจผู้ปฏิบัติงาน ก.ค.–ต.ค. 2569 ถ่วงน้ำหนัก · ความสัมพันธ์จากผู้ที่ยังทำงาน ไม่ใช่เหตุและผล และความตั้งใจออกไม่เท่ากับการออกจริง · รายงานการศึกษา บทที่ 7

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

การตีความของคณะวิจัย

ตัวเลขว่าขาดน้อยลง อาจซ่อนงานที่ย้ายไปให้ครอบครัว

ส่วนขาดที่ลดลงเกิดได้สามทาง คือทำงานได้มากขึ้น ลดเป้าหมายลง หรือย้ายงานให้ครอบครัวและวิชาชีพอื่น ต้องดูว่าเกิดจากทางใด

รายงานจึงควรบอกคู่กันว่า เพิ่มทรัพยากรอะไร เปลี่ยนเป้าหมายอะไร และใครรับงานเพิ่ม

คนทำงานมีงานดูแลที่บ้านด้วย

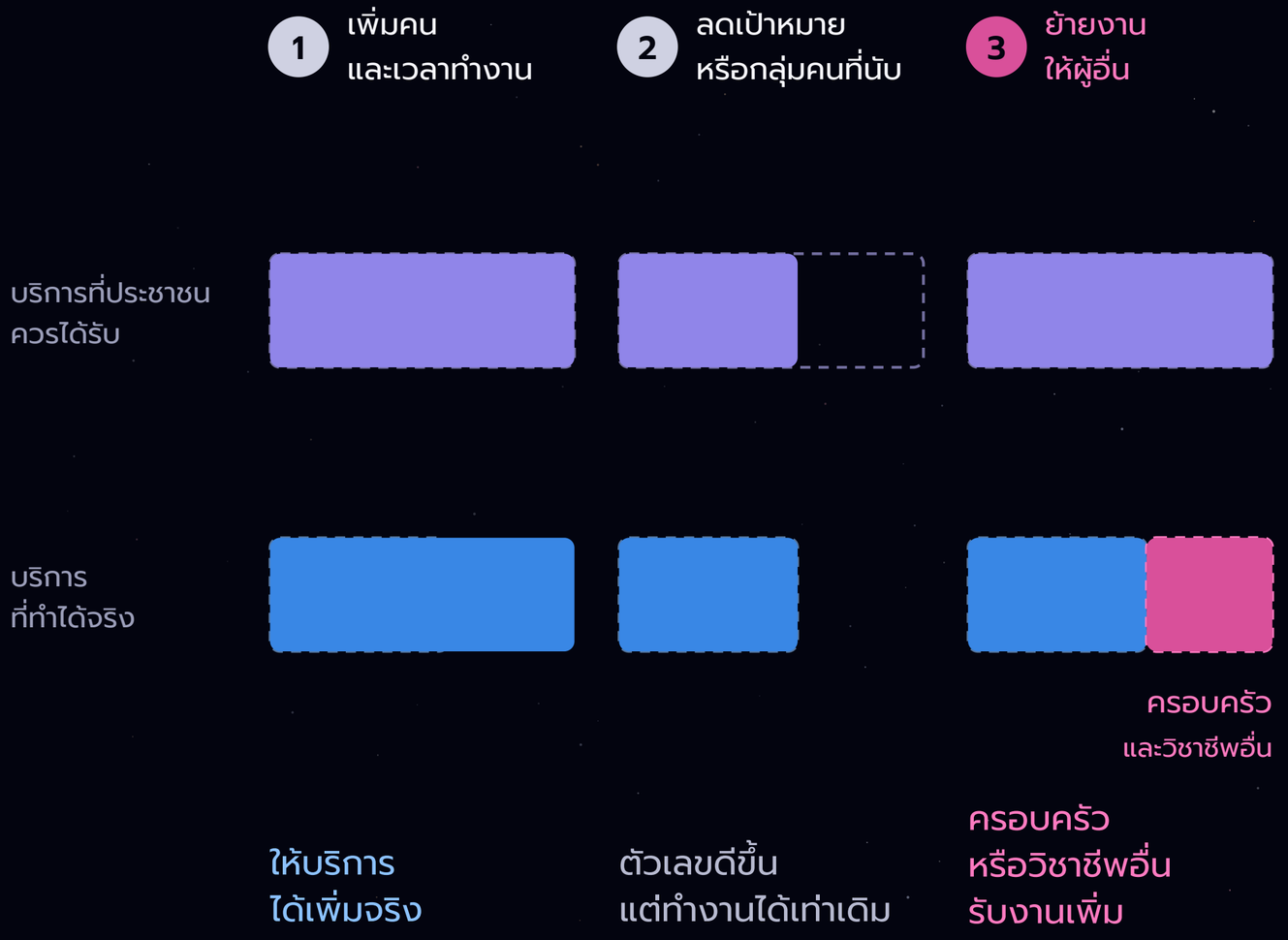
43%

ของผู้ตอบเป็นผู้ดูแลหลัก ของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในครอบครัว

34%

คิดเกษียณก่อนกำหนด หรือลดชั่วโมงทำงาน

การสำรวจผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2569 · คนละคำถาม ยังไม่ได้บอกว่างานดูแลทำให้คิดลดงาน



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

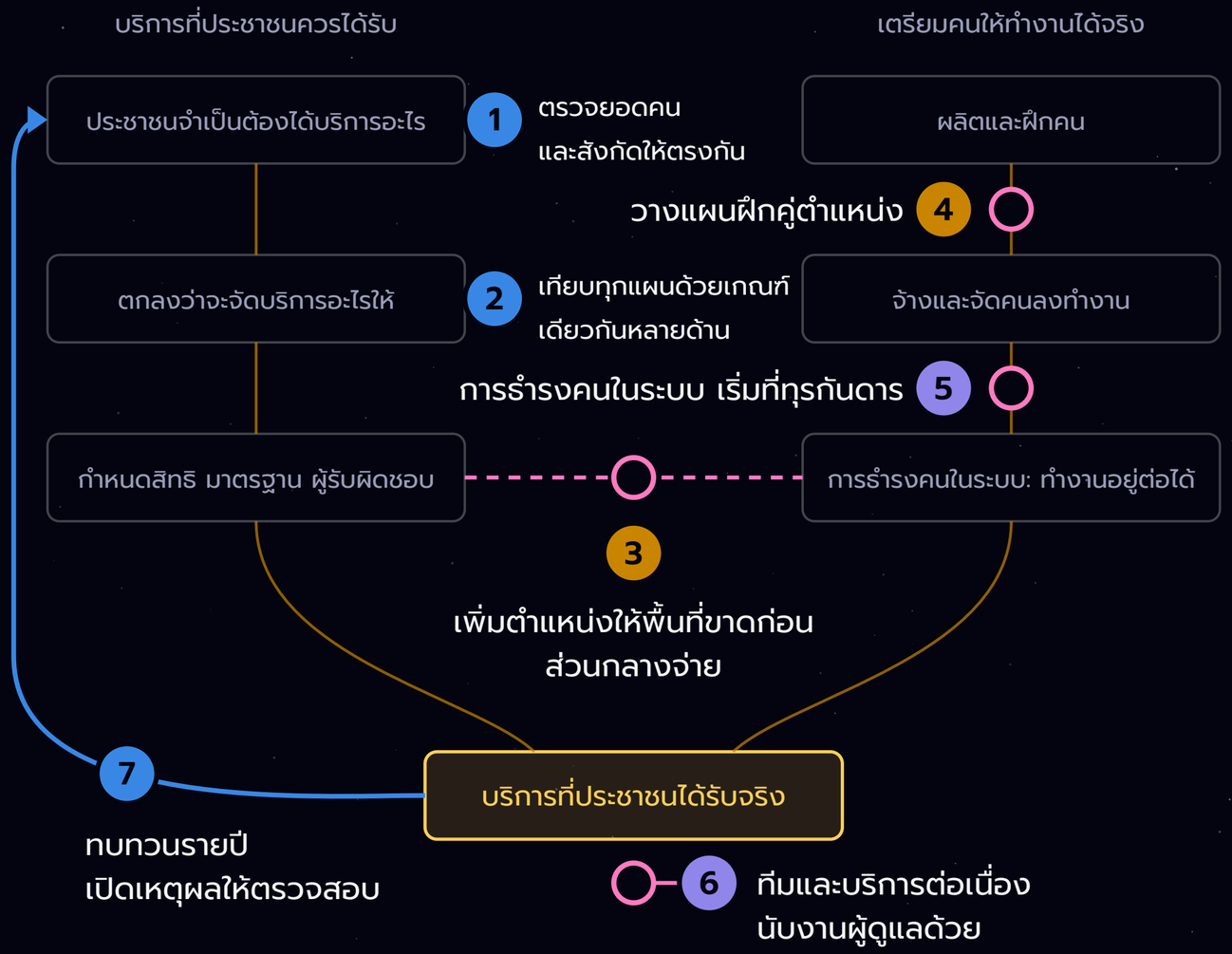
ข้อเสนอ · การตีความของคณะวิจัย

ข้อเสนอเจ็ดข้อ เพื่อแก้ปัญหาสี่จุด

ข้อมูล ตำแหน่ง การฝึก และการธำรงคนในระบบต้องทำต่อกัน จึงจะเกิดบริการที่ประชาชนได้รับจริง

ตัวเลขคือลำดับที่ต้องทำ · สีบอกแนวคิดที่ใช้

- **การจัดให้มีบริการทางสังคม**
  ใครควรได้บริการอะไร
- **วงจรสะสม (Myrdal)**
  นโยบายช่วยพื้นที่เสียเปรียบ
- **เศรษฐศาสตร์แรงงาน**
  ช่วยคนอยู่ต่อและนับผู้รับภาระ



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ส่งต่อวงเสวนา | การตีความของคณะวิจัย

ข้อมูลบอกผลและภาระของแต่ละทางเลือก แต่เลือกแทนเราไม่ได้

1 ความจำเป็นใดควรถูกนับก่อน

2 ใครควรเป็นผู้จ้าง และอะไรกำหนดว่าพื้นที่รับคนได้เท่าใด

3 ใครรับภาระของความไม่เพียงพอ ระหว่างรัฐ ผู้ทำงาน ครอบครัว และชุมชน

4 ใครควรมีสิทธิ์ตัดสินว่าเท่าใดจึงเพียงพอ และฉันทามติควรสร้างผ่านช่องทางใด

ตรวจทุกผล และลองเปลี่ยนแผนเองได้ใน
Workforce Lab

psitthirat.github.io/HRH-model

ขอบคุณหน่วยงานที่ให้ข้อมูล และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ตอบแบบสำรวจ

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)